

TEMA 6.18 • INFECTOLOGÍA

Varicela y Herpes Zóster

PERFIL EUNACOM 1.05.1.018

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Varicela y Herpes Zóster

Varicela

- **Agente:** Virus varicela-zóster (VVZ / HHV-3)
- **Clínica:**
 - Exantema **pruriginoso, polimorfo** (pápulas → vesículas → pústulas → costras)
 - **Siempre afecta la cabeza** (distribución céfalo-caudal)
 - Pródromo febril previo al exantema
 - Contagia hasta que TODAS las lesiones estén en costra

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Contraindicado: Aspirina/AAS en varicela (riesgo Síndrome de Reye = encefalopatía + hepatitis grave).

Indicaciones de Aciclovir en Varicela

TABLA 6.18.1: INDICACIÓN VS JUSTIFICACIÓN	
INDICACIÓN	JUSTIFICACIÓN
Edad > 13 años (adultos)	Mayor riesgo de complicaciones virales
Segundo caso en la familia (contacto domiciliario)	Mayor inóculo viral
Varicela grave o hemorrágica (> 100 lesiones)	Enfermedad severa
Paciente inmunosuprimido	Alto riesgo vital

- **Aciclovir:** 800 mg VO × 5 veces/día × 7 días (dosis doble respecto a herpes simple) - **Valaciclovir:** 1 g VO × 3 veces/día × 7 días

Complicaciones de la Varicela

TABLA 6.18.2: TIPO VS AFECTA A		
TIPO	AFECTA A	CLÍNICA
Sobreinfección bacteriana (Staphylococcus, Streptococcus)	Niños	Erisipela, celulitis → Cloxacilina o cefalosporina 1ª gen
Complicaciones virales (neumonitis, encefalitis, hepatitis)	Adultos	Graves → Aciclovir EV
Cerebelitis post-varicela (inmune)	Niños	Síndrome cerebeloso autolimitado (1-2 semanas), sin secuelas

Herpes Zóster

- **Patogenia:** Reactivación del VVZ latente en ganglios sensoriales (nunca se elimina tras la varicela).
- **Factores:** Adulto mayor, inmunosupresión (VIH en zonas múltiples), estrés.
- **Clínica:** Eritema + vesículas siguiendo un **dermatomo** (no cruza la línea media). Puede precederse de dolor quemante neuropático.
- **Diagnóstico:** Clínico.
- **Tratamiento:** Aciclovir 800 mg × 5 veces/día × 7 días o Valaciclovir 1 g × 3 veces/día × 7 días.
 - Objetivo: prevenir la **neuralgia post-herpética** (dolor crónico residual).
- **Aislamiento:** Respiratorio (igual que varicela, VVZ es muy contagioso por aerosoles).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Niño de 5 años con varicela de 3 días de evolución presenta fiebre persistente y placa eritematosa con bordes nítidos en pierna derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Varicela y Herpes Zóster. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Varicela: exantema pruriginoso polimorfo (pápulas-vesículas-pústulas-costras), SIEMPRE afecta la cabeza, distribución cefalocaudal. Contagia hasta que todo sea costra.
- Aspirina CONTRAINDICADA en varicela (síndrome de Reye). Tratamiento: paracetamol.
- Indicaciones de aciclovir: >13 años, 2do caso familiar, varicela grave, inmunodeprimido. Dosis: 800 mg x5/día (DOBLE de herpes simple) o valaciclovir 1g c/8h, 7 días.
- Complicaciones: bacterianas en niños (grampositivos, cloxacilina), virales en adultos (neumonitis/encefalitis, aciclovir EV), inmunes (cerebelitis post-varicela, autolimitada).
- Herpes zóster: recurrencia VVZ en adulto mayor/inmunodeprimido/estrés. Vesículas en dermatomo, no cruza línea media. Zóster recurrente/múltiple = sospechar VIH.
- Tratamiento zóster: aciclovir 800 mg x5/día o valaciclovir 1g c/8h por 7 días, para prevenir neuralgia post-herpética.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (VARICELA Y HERPES ZÓSTER)

PREGUNTA 1

Niño de 5 años con varicela de 3 días de evolución presenta fiebre persistente y placa eritematosa con bordes nítidos en pierna derecha. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el tratamiento?

- A) Complicación viral de varicela; aciclovir endovenoso
- B) Sobreinfección bacteriana (erisipela); cloxacilina o cefalosporina de primera generación
- C) Cerebelitis post-varicela; observación
- D) Fascitis necrotizante; penicilina G EV más clindamicina y cirugía
- E) Reacción adversa al paracetamol; suspender medicación

PREGUNTA 2

Adulto mayor de 72 años presenta vesículas agrupadas sobre una base eritematosa que sigue la distribución de un dermatomo torácico izquierdo, sin pasar la línea media, con dolor tipo ardor. ¿Cuál es el objetivo principal del tratamiento antiviral?

- A) Curar la infección por completo
- B) Prevenir el contagio a otras personas
- C) Disminuir el riesgo de neuralgia post-herpética
- D) Prevenir la diseminación a otros dermatomas
- E) Evitar la sobreinfección bacteriana de las vesículas

PREGUNTA 3

Hombre de 30 años, previamente sano, presenta herpes zóster en dermatomo T6 derecho. Hace 4 meses tuvo otro episodio de herpes zóster en región oftálmica. ¿Cuál es la conducta más importante además del tratamiento antiviral?

- A) Solicitar hemograma completo
- B) Solicitar ELISA para VIH
- C) Iniciar profilaxis con aciclovir diario indefinido
- D) Solicitar biopsia de las vesículas para cultivo viral
- E) Solicitar TAC de tórax para descartar neoplasia oculta

RESUMEN: VARICELA Y HERPES ZÓSTER

Esta clase aborda la varicela y el herpes zóster, ambos causados por el virus varicela-zóster (VVZ). La varicela se presenta con exantema pruriginoso polimorfo (pápulas, vesículas, pústulas, costras) que siempre afecta la cabeza y sigue distribución cefalocaudal. Contagia hasta que todas las lesiones estén en costra. Diagnóstico absolutamente clínico. Tratamiento sintomático con paracetamol; aspirina absolutamente contraindicada (riesgo de síndrome de Reye). El aciclovir se indica en: mayores de 13 años, segundo caso familiar, varicela grave (neumonía, hemorrágica, >100 lesiones) e inmunodeprimidos. Dosis: aciclovir 800 mg 5 veces/día o valaciclovir 1 g c/8h por 7 días (el doble de la dosis para herpes simple). Las complicaciones incluyen: sobreinfección bacteriana (grampositivos, frecuente en niños, tratamiento con cloxacilina/cefalosporinas), complicaciones virales (neumonitis, encefalitis, hepatitis, frecuentes en adultos, aciclovir endovenoso), y cerebelitis post-varicela (niños, autolimitada). El herpes zóster es la recurrencia del VVZ, característico de adultos mayores, inmunodeprimidos o estrés. Presenta eritema y vesículas siguiendo un dermatomo, sin pasar la línea media. El zóster recurrente o múltiple debe hacer sospechar VIH. Tratamiento con aciclovir 800 mg 5 veces/día o valaciclovir 1 g c/8h por 7 días, para disminuir el riesgo de neuralgia post-herpética.